想定Q&A集

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

戦略会議
想定Q&A集（2025年度2月実績ベース・3月手術/土曜日データ反映）

作成日: 令和8年3月30日
対象期間: 2025年度4月～3月（年度完結）および3月単月
対象病院: 大橋病院（3病院比較含む）
作成部署: 経営企画部

---

1. 収支・予算関連（7問）

Q1-1. 今年度の診療収入は予算に対してどの程度の乖離があるのか。年度末の着地見通しはどうか。

【結論】
累計で約3.2億円の予算未達（予算対比97.9%）であり、年度末には約3.5億円程度の未達で着地する見通しである。

【根拠データ】
・資料1-1：診療費総額（入院+外来）累計 14,818,646千円に対し、予算15,141,036千円、差額 △322,390千円（予算対比97.9%）
・入院：累計9,644,523千円 vs 予算9,673,981千円（△29,458千円、99.7%）
・外来：累計5,174,123千円 vs 予算5,467,055千円（△292,932千円、94.6%）
・外来の予算未達が全体の約91%を占めている

【補足/対策】
外来収入の未達が主因である。外来患者数が予算比で月平均55.9人少ない（資料1）ことが最大の要因。3月の挽回だけでは累計の乖離を埋めることは困難であり、来年度予算策定時に外来患者数の前提を見直す必要がある。なお、前年度対比では収入合計は+551,485千円（+3.6%）と着実に増加しており、予算が前年度実績を上回る高い水準で設定されていた面がある点にも留意が必要である。

Q1-2. 外来収入が予算を大幅に下回っている原因は何か。

【結論】
一日平均外来患者数が予算比で大幅に減少していることが主因。ただし、外来単価は予算を上回っている。

【根拠データ】
・資料1-1：一日平均外来患者数 累計852.1人 vs 予算910.0人（△57.9人）
・資料1：大橋病院 外来一日平均患者数 累計851.6人 vs 予算907.5人（△55.9人、△6.2%）
・一方、外来単価は累計22,628円 vs 予算22,647円とほぼ予算並み（資料1）
・資料1-1：初診患者数 累計16,688人 vs 前年度18,134人（△1,446人、△8.0%）
・資料7-2：紹介件数 累計12,652件 vs 前年度15,022件（月平均△102件）

【補足/対策】
初診患者の減少（前年度比△1,446人）と紹介件数の減少（月平均1,150件 vs 前年度1,252件）が患者数減の主因。資料10によると紹介患者数の目標は月1,300件に対し実績は月平均1,150件と未達。地域連携強化、医師による医療機関訪問の継続（現在月平均10.5件）、紹介元医療機関への積極的なアプローチが必要。

Q1-3. 大橋病院の粗利益が予算を大幅に下回っているが、どう認識しているか。

【結論】
4～2月累計の粗利益は122,991千円で、予算552,078千円に対して△429,087千円（△77.7%）と極めて深刻な状況である。

【根拠データ】
・資料1：大橋病院 累計 粗利益122,991千円 vs 予算552,078千円（△429,087千円）
・粗利益率：0.8% vs 予算3.4%（△2.6ポイント）
・収入面：収入合計 15,841,950千円 vs 予算16,153,885千円（△311,935千円、△1.9%）
・支出面：支出合計 15,718,959千円 vs 予算15,601,807千円（+117,152千円、+0.8%）
・特に人件費支出が予算比+105,674千円（+1.6%）と超過

【補足/対策】
収入減と支出増の双方が粗利益を圧迫している。収入は外来の△341,216千円（△6.2%）が最大。支出では人件費が予算を1.6%上回っている。医療経費も+103,650千円。コスト管理の強化と収入増加策の両面からの対応が急務。ただし、前年度対比では粗利益は55,297→122,991千円（+122.4%）と2倍以上に改善しており、3病院中唯一の粗利益改善である点は評価できる。予算の高い設定水準と実績ベースの改善傾向を区別して議論する必要がある。

Q1-4. 基本金組入前当年度収支差額が大幅な赤字となっているが、改善策はあるのか。

【結論】
大橋病院の基本金組入前当年度収支差額は累計△1,376,980千円と、予算△906,788千円から△470,192千円の悪化。賞与引当金含みでは△1,924,610千円と深刻。

【根拠データ】
・資料1：大橋病院 累計 基本金組入前当年度収支差額 △1,376,980千円（予算比 △470,192千円、△51.9%）
・賞与引当金繰入額含む：△1,924,610千円（前年度差 △714,767千円）
・2月単月：18,323千円（予算66,409千円に対し△48,086千円）

【補足/対策】
事業活動収支項目他（減価償却費等）の影響が大きい。減価償却額は月平均約113,160千円と経年的に増加傾向。設備投資計画の見直しと収入増加の両面での対策が必要。来年度に向けて投資対効果の厳密な検証を実施すべき。

Q1-5. 査定率・査定額が目標を上回っているが、具体的な対策は。

【結論】
査定率は累計平均0.54%で目標0.40%を上回り、査定額も累計74,349千円で目標55,000千円を大幅に超過している。

【根拠データ】
・資料10：査定率 平均0.54% vs 目標0.40%
・査定額 累計74,349千円 vs 目標55,000千円（年間ベース）
・特に7月0.86%、8月0.77%と高い月があった

【補足/対策】
診療科へのヒアリングとフィードバックを実施中（資料10記載）。高査定率の診療科を特定し、レセプト点検の強化、算定ルールの再教育を行う。12月は0.44%と目標値まで改善しており、直近の取組み効果は出始めている。

Q1-6. 入院収入は予算をほぼ達成しているように見えるが、安心してよいのか。

【結論】
累計で予算対比99.7%と一見堅調だが、4月の大幅黒字（+94,175千円）を除くと5月以降は概ね予算割れが常態化しており、楽観視できない。

【根拠データ】
・資料1-1：入院診療費 累計9,644,523千円 vs 予算9,673,981千円（△29,458千円）
・月別予算対比：4月111.0%以外は、95.6%～104.9%で推移し、10月以降は95.6%→96.2%→97.6%→95.9%→99.6%と低迷
・病床稼働率 累計88.9% vs 予算92.0%（△3.1ポイント）

【補足/対策】
入院単価は累計101,517円で予算98,511円を上回っている（+3,006円）が、病床稼働率の低さ（88.9%）が患者数を押し下げている。ベッドコントロールの更なる強化が必要。

Q1-7. 入院単価が前年度を上回っているのは評価できるが、持続可能か。

【結論】
入院単価は累計101,517円で前年度97,592円から+3,925円と改善。DPC期間II以内退院率や特定入院料算定率の改善が寄与しており、一定の持続性はある。

【根拠データ】
・資料1-1：入院単価 累計101,517円 vs 前年度97,592円（+3,925円）
・資料1：大橋 入院一日一人当たり診療額 累計100,719円 vs 前年度96,652円（+4,067円、+4.2%）
・資料10：DPC期間II以内退院割合 71.9%（目標70.0%達成）
・資料4：ICU算定率 79.6%（前年71.5%から+8.1ポイント改善）

【補足/対策】
平均在院日数の短縮（8.9日、前年度9.2日）と特定入院料算定率の改善が単価向上に寄与。引き続きクリニカルパスの活用（使用率65.1%で目標60%達成）や入退院支援の強化で維持可能と考える。

---

2. 入院部門関連（4問）

Q2-1. 病床稼働率が目標92%に対して88.9%と低迷している原因は何か。

【結論】
7月～10月に85～87%台まで落ち込んだことが年間平均を押し下げている。新入院患者数は前年度を上回っているが、在院日数短縮が稼働率を押し下げている。

【根拠データ】
・資料1-1：病床稼働率 累計88.9% vs 予算92.0%（△3.1ポイント）
・月別推移：7月86.8%→8月86.8%→9月85.9%→10月86.7%（4か月連続87%未満）
・一方、2月は94.0%と高稼働を達成
・新入院患者数 累計9,595人 vs 前年度9,359人（+236人）
・平均在院日数 8.9日 vs 前年度9.2日（△0.3日短縮）

【補足/対策】
在院日数短縮は効率性係数向上に寄与するが、稼働率と相反する。新入院患者をさらに増やすことで稼働率を維持する戦略が必要。資料10の退院前

日15時退院決定割合は83.7%（目標80%達成）と改善しており、ベッドコントロールの仕組みは機能している。

Q2-2. 平均在院日数が短縮しているが、効率性係数にどう影響しているか。

【結論】
平均在院日数は8.9日（前年度9.2日）と目標9.0日を達成しており、効率性係数の改善に貢献している。

【根拠データ】
・資料1-1：平均在院日数 累計8.9日 vs 予算9.0日 vs 前年度9.2日
・資料10：DPC期間II以内退院割合 71.9%（目標70.0%、前年度70.0%から改善）
・予定入院のDPC期間II以内退院割合 77.5%（目標75.0%達成）
・緊急入院のDPC期間II以内退院割合 60.4%（目標60.0%達成）

【補足/対策】
手術あり患者のDPC期間II以内退院割合は75.3%（目標70%）と高い。手術なし患者は66.1%（目標70%に未達）であり、内科系疾患の退院支援強化が課題。

Q2-3. 特定入院料病棟（ICU/HCU/SCU）の算定状況はどうか。

【結論】
ICUとSCUは前年度から大幅に改善。HCUは稼働率が一時低下したが2月に回復。

【根拠データ】
・資料4/資料10：
  ・ICU：算定率79.6%（前年度71.5%、+8.1pt）、稼働率87.4%（目標80%達成）、金額累計197,549千円（前年度比+20,947千円）
  ・HCU：算定率73.4%（前年度72.9%、+0.5pt）、稼働率80.9%（目標80%達成）、2月は91.4%と年度最高
  ・SCU：算定率95.6%（前年度90.2%、+5.3pt）、稼働率95.8%（目標90%達成）

【補足/対策】
ICUの改善が顕著で、金額ベースで年間約2,100万円の増収効果。一方、HCUは9月に稼働率67.5%まで低下した時期があり、安定的な患者確保が課題。SCUは100%超の月もあり、病床不足の可能性も検討すべき。

Q2-4. 入退院支援加算の算定状況は改善しているか。

【結論】
入退院支援加算は累計3,116件（月平均283.3件）で、前年度比+147件と着実に増加している。

【根拠データ】
・資料8：入退院支援加算 累計3,116件（月平均283.3件）vs 前年度2,969件（月平均271.0件）
・金額：累計24,574千円（月平均2,234千円）vs 前年度25,896千円（月平均2,158千円）→月平均では増加
・退院患者における割合：32.4%（前年度34.0%からやや低下）
・入院時支援加算：累計1,047件（月平均95.2件）vs 前年度1,043件（月平均99.6件）
・介護支援連携指導料：過去12か月累計74件（施設基準要件48件を充足）

【補足/対策】
件数は増加しているが、退院患者に占める割合はやや低下。病棟別では7A病棟が月平均60.1件と最多で、4A病棟が41.5件。病棟間のばらつきを是正し、特に6B病棟（月平均29.1件）の底上げが課題。

3. 外来部門関連（4問）

Q3-1. 外来患者数が前年度を大きく下回っている。どう挽回するのか。

【結論】
一日平均外来患者数は852.1人で、前年度895.4人から△43.3人（△4.8%）と減少。紹介件数の減少と初診患者の減少が主因。

【根拠データ】
・資料1-1：一日平均外来患者数 累計852.1人 vs 前年度895.4人（△43.3人）
・初診患者数 累計16,688人 vs 前年度18,134人（△1,446人、△8.0%）
・初診率 7.4% vs 前年度7.8%（△0.4pt）
・資料7：紹介率 月平均85.9% vs 前年度87.1%（△1.2pt）
・資料7-2：紹介件数累計 2025年度各科合計で前年度比減少（整形外△543件が最大）

【補足/対策】
資料7-2によると、整形外科（前年度2,192→1,649件、△543件）、消化内科（2,574→2,291件、△283件）、耳鼻科（1,461→1,279件、△182件）の紹介減が大きい。紹介元医療機関別では明大前クリニック（△10件）をはじめ複数施設で減少。個別の関係強化施策が必要。

Q3-2. 外来単価は改善しているが、何が寄与しているのか。

【結論】
外来単価は累計22,841円で前年度21,551円から+1,290円（+6.0%）と改善。化学療法と高額薬剤の使用増が主な要因。

【根拠データ】
・資料1-1：外来単価 累計22,841円 vs 前年度21,551円（+1,290円）
・資料2：外来化学療法加算算定件数 累計2,939件 vs 前年度2,514件（+425件、+16.9%）
・外来化学療法金額 累計21,823千円 vs 前年度17,436千円（+4,387千円、+25.2%）
・資料1：大橋 外来一日一人当たり診療額 累計22,628円 vs 前年度21,439円（+1,189円、+5.5%）

【補足/対策】
外来化学療法の件数増加（特に外科：前年度1,338→1,481件、消化器内科：394→478件、泌尿器科：90→199件）が単価向上に大きく寄与。一日あたり予約患者数も12.7人と前年度10.6人から+2.1人増加。今後も化学療法室の効率的運用を継続する。

Q3-3. 紹介率・逆紹介率は地域医療支援病院の基準を満たしているか。

【結論】
紹介率85.9%、逆紹介率89.8%で、いずれも地域医療支援病院基準（紹介率80%・逆紹介率40%）を十分に満たしている。

【根拠データ】
・資料7：紹介率 月平均85.9%（基準(1)80%以上を達成）
・逆紹介率 月平均89.8%（基準(2)40%以上を大幅に達成）
・診療報酬算定要件の紹介割合 月平均97.2%（基準50%以上）
・逆紹介割合 月平均71.2パーミル（基準30パーミル以上）

【補足/対策】
基準は満たしているが、紹介率は前年度87.1%から△1.2pt低下。特に1月は82.7%と低下した月もある。紹介件数自体は前年度比で月平均△102件減少しており、紹介率の維持は初診患者数の減少に助けられている側面もある。実質的な紹介件数の増加が本質的な課題。

Q3-4. 紹介受入れの拒否状況はどうなっているか。改善できるのか。

【結論】
2月の紹介受入拒否は11件。「ベッド満床」が最多の理由で、特定の診療科に集中している。

【根拠データ】
・資料7-1：2026年2月の拒否11件の内訳
　・ベッド満床：7件（呼吸器2、消化器1、整形3、皮膚1）
　・処置困難（医師不在等）：3件（外科1、婦人科1、整形1）
　・対応困難：1件（整形1）
・整形外科関連の拒否が5件と最多
・過去12ヶ月で拒否率30%超かつ6件以上の施設は「あきもとクリニック」1件のみ

【補足/対策】
ベッド満床による拒否が主因であり、病床稼働率88.9%との矛盾は一時的な病棟別偏在が原因と考えられる。病棟横断的なベッドコントロールの強化と、特に整形外科病床の運用見直しが必要。

---

4. 3病院比較関連（5問）

Q4-1. 3病院の中で大橋病院の収支状況はどのような位置付けか。

【結論】
大橋病院は3病院中、粗利益率が最も低く（0.8%）、経営的に最も厳しい状況にある。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 粗利益率
　・大森病院：2.1%（粗利益760,402千円）
　・大橋病院：0.8%（粗利益122,991千円）
　・佐倉病院：0.5%（粗利益90,213千円）
・予算比の粗利益乖離
　・大森：△649,731千円（△46.1%）
　・大橋：△429,087千円（△77.7%）
　・佐倉：△1,623千円（△1.8%）

【補足/対策】
佐倉病院は粗利益率では大橋より低いが、予算との乖離は小さい（△1.8%）。大橋病院は予算との乖離が最も大きく（△77.7%）、予算策定の精度と収支改善の両面で課題がある。大森病院は規模のメリットで粗利益額は最大だが、予算比では△46.1%と未達。

Q4-2. 手術件数は3病院比較でどうか。大橋は増やせるのか。

【結論】
大橋病院の年度合計手術件数は6,336件で、前年度6,162件から+174件（+2.8%）と着実に増加。3月単月は479件（前年518件、△39件）とやや減少したが、年度全体では前年度を上回った。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 手術件数（3病院比較）
　・大森病院：11,931件（前年度比+406件、+3.5%）予算比+1,112件

  ・大橋病院：5,857件（前年度比+213件、+3.8%）予算比+395件
  ・佐倉病院：5,704件（前年度比△201件、△3.4%）予算比+236件
・資料3：大橋病院 年度合計（4-3月）6,336件 vs 前年度6,162件（+174件、+2.8%）
・3月単月：479件（前年518件、△39件）
・診療科別年度合計（資料3）：
  ・外科：976件（前年945件、+31件）
  ・整形外科：767件（前年774件、△7件）
  ・産婦人科：319件（前年256件、+63件、+24.6%）←最大の増加率
  ・眼科：2,502件（前年2,468件、+34件）
  ・心外科：258件（前年271件、△13件）
  ・泌尿器科：429件（前年417件、+12件）
・全身麻酔：年度合計3,261件（前年3,186件、+75件）

【補足/対策】
急性期充実体制加算の施設基準（全麻2,000件/年以上、緊急手術350件/年以上）に対し、全麻3,261件で基準2,000件を大幅に超過、緊急手術も4-2月で582件と基準350件を十分に充足。産婦人科が前年度比+24.6%と著しい伸びを示す一方、心外科（△13件）・整形外科（△7件）はやや減少。3月単月が前年比△39件となった要因の分析と、来年度の件数維持策の検討が必要。ダヴィンチ手術は月平均10.2件（目標10件達成、資料10）。

Q4-3. 外来患者数の減少は大橋病院だけの問題か。

【結論】
3病院すべてで外来患者数は前年度比・予算比ともに減少しており、大橋病院だけの問題ではない。ただし、大橋の減少幅が相対的に大きい。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 一日平均外来患者数（予算比）
  ・大森病院：1,940.1人（予算比△88.7人、△4.4%）
  ・大橋病院：851.6人（予算比△55.9人、△6.2%）←最大の乖離率
  ・佐倉病院：1,027.5人（予算比△49.5人、△4.6%）
・2月単月の新患者数（前年比）
  ・大森：142.0人（△13.4人、△8.6%）
  ・大橋：61.5人（△7.1人、△10.3%）←最大の減少率
  ・佐倉：60.3人（△10.4人、△14.7%）

【補足/対策】
外来患者減は法人全体の課題だが、大橋病院は予算比の乖離率が最大（△6.2%）。ただし外来単価は大橋22,628円（予算比△0.1%）と概ね維持できており、大森・佐倉は単価が予算を上回っている。患者数減をどこまで単価で補えるかが今後の鍵。

Q4-4. 3病院の人件費比率に問題はないか。

【結論】
大橋病院の人件費は予算を上回っており、収入に対する人件費比率が他院と比較しても高い水準にある。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 人件費支出（予算比）
  ・大森病院：14,237,155千円（予算比+6,515千円、+0.0%）
  ・大橋病院：6,519,108千円（予算比+105,674千円、+1.6%）←最大の超過率
  ・佐倉病院：7,170,706千円（予算比△256,855千円、△3.5%）
・収入に対する人件費比率（概算）

・大森：38.6%
・大橋：41.2%
・佐倉：39.6%

【補足/対策】
大橋病院は人件費率41.2%と3病院中最も高い。2月単月では440,637千円と予算406,385千円を34,252千円（+8.4%）上回った。佐倉が予算比△3.5%と人件費を抑制できていることとの対比が顕著。人員配置の最適化と労働生産性の向上が課題。

Q4-5. 大橋病院の入院単価は3病院中どのような位置付けか。

【結論】
大橋病院の入院単価は3病院中最も高く、収益性の面では強みと言える。

【根拠データ】
・資料1：4～2月累計 入院一日一人当たり診療額
・大森病院：94,747円（予算比+747円、+0.8%）
・大橋病院：100,719円（予算比+2,208円、+2.2%）←最高
・佐倉病院：85,521円（予算比△978円、△1.1%）
・大橋は予算比でもプラスであり、前年度比でも+4,067円（+4.2%）

【補足/対策】
大橋病院の入院単価の高さは、ICU/HCU/SCUの特定入院料算定率の改善（資料4）や、救急医療管理加算の適正算定（資料10）が寄与。平均在院日数の短縮（8.9日）も単価を押し上げる要因。この強みを活かしつつ、患者数を増やして収入総額を伸ばすことが重要。

---

5. 各部門（化学療法・手術・リハビリ等）関連（5問）

Q5-1. 外来化学療法の件数が大幅に増えているが、体制は十分か。

【結論】
外来化学療法加算の算定件数は累計2,939件（月平均267件）で前年度比+425件（+16.9%）と大幅増加。体制面の検討が必要な水準に達している。

【根拠データ】
・資料2：外来化学療法加算算定件数 累計2,939件 vs 前年度2,514件（+425件）
・金額：累計21,823千円 vs 前年度17,436千円（+4,387千円、+25.2%）
・一日あたり予約患者数：12.7人 vs 前年度10.6人（+2.1人）
・算定実患者数：月平均185人 vs 前年度170人（+15人）
・曜日別では水曜日（月平均70.5人）と木曜日（69.5人）に集中

【補足/対策】
水曜・木曜への集中が見られるため、他の曜日への分散が必要。10月は月320件と年度最高を記録。特に外科（累計1,481件、前年度+255件）と消化器内科（478件、+117件）、泌尿器科（199件、+120件）の増加が著しい。看護師配置やベッド数の再検討を推奨。

Q5-2. リハビリテーションの算定が前年度を下回っているが、原因は何か。

【結論】
リハビリ算定単位数は累計27,354単位で前年度28,621単位から△1,267単位（△4.4%）と減少。特に運動器リハと脳血管リハの減少が大きい。

【根拠データ】
・資料5：2025年度 算定単位数 累計27,354単位 vs 前年度28,621単位（△1,267単位）
・算定金額 累計61,875千円 vs 前年度64,480千円（△2,605千円、△4.0%）
・内訳（前年度差）：
  ・脳血管リハ：10,929単位（前年度12,232、△1,303）
  ・運動器リハ：9,838単位（前年度10,670、△832）
  ・廃用リハ：2,115単位（前年度884、+1,231）←大幅増
・一日平均単位数：103.0単位 vs 前年度109.8単位（△6.8単位）

【補足/対策】
12月以降は回復傾向にあり（12月+283、1月+173、2月+482単位）、直近3か月は前年度を上回っている。廃用症候群リハは2倍以上に増加しており、高齢患者への対応強化の効果が出ている。脳血管・運動器リハの対象患者確保とスタッフ体制の充実が課題。

Q5-3. 放射線治療の算定が減少しているが、どう対応するのか。

【結論】
放射線治療の算定金額は累計121,884千円で前年度138,356千円（4-2月分推計）から約16,472千円の減少。ただし直近では回復傾向。

【根拠データ】
・資料9：2025年度 算定金額 累計121,884千円（月平均11,080千円）vs 前年度144,784千円（月平均12,065千円）
・2月は16,326千円と年度最高を記録し、前年度同月比+6,862千円
・IMRT：累計1,779件 vs 前年同期1,985件（△206件）だが、2月は236件と年度最高
・体外照射：累計1,926件 vs 前年同期2,431件（△505件）だが、2月は251件と回復

【補足/対策】
がん種別では乳がんの新規患者が累計147件（前年度196件）と減少が顕著。一方、肺がんは72件（前年度55件）と増加。11月に月7,588千円と大幅減があったが、2月は16,326千円と大きく回復。放射線治療管理料の算定件数も2月は25件と増加傾向にあり、今後の推移を注視。

Q5-4. 救急体制の改善状況はどうか。謝絶率は目標を達成しているか。

【結論】
救急車謝絶率は20.2%で目標30.0%を大きく上回って達成。直入率も46.4%で目標40.0%を達成している。

【根拠データ】
・資料10：
  ・救急車要請件数 累計3,603件（月平均327.5件）
  ・救急車受入件数 累計2,767件（月平均251.5件）vs 目標月280件
  ・謝絶率 平均20.2% vs 目標30.0%（前年度36.0%から大幅改善）
  ・直入率 46.4% vs 目標40.0%（前年度41.5%から改善）
・資料1-1：救急医療管理加算合計 累計3,277人 vs 前年度3,084人（+193人）

【補足/対策】
謝絶率は全月で目標を達成しており、特に9月15.8%、12月15.0%と良好。ただし救急車受入件数は月平均251.5件で目標280件には未達。受入件数の絶対数を増やすことが次のステップ。

Q5-5. 後発医薬品の使用状況は適正か。

【結論】
後発医薬品指数（数量ベース）は95.9%で目標90%を大幅に達成。金額ベース（入院）も94.1%で目標80%達成。

【根拠データ】
・資料6：後発医薬品指数（数量ベース）累計95.9% vs 目標90%
・後発医薬品使用体制加算1（47点）の要件90%以上を安定的に満たす
・資料10：後発医薬品割合 金額ベース（入院）平均94.1% vs 目標80%
・資料6：入院 金額ベース 年度推移 2022年度87.0%→2023年度87.8%→2024年度88.8%→2025年度94.1%と着実に向上
・ただし2月は入院金額ベース88.3%とやや低下

【補足/対策】
後発品のある先発医薬品の使用が多い診療科として眼科（入院303千円）、外科（219千円）、リウマチ科（190千円）が挙がっている（資料6）。個別薬剤ではアクテムラ、アナペイン、フォシーガ等が先発品として使用されており、後発品への切替可能性を検討する。

---

6. 今後の見通し・対策関連（4問）

Q6-1. 来年度に向けて最も注力すべき経営課題は何か。

【結論】
最優先課題は「外来患者数の回復」と「病床稼働率の向上」の2点。この2つで約3億円以上の収入改善が見込める。

【根拠データ】
・外来：患者数予算比△55.9人/日 x 外来単価22,628円 x 266日 ≒ 約3.4億円の機会損失
・入院：稼働率88.9% vs 予算92.0%の差（約3.1pt）x 320床 ≒ 約10床分の未活用。入院単価100,719円 x 10床 x 335日 ≒ 約3.4億円の機会損失
・資料10：紹介患者数 月平均1,150件 vs 目標1,300件（△150件/月）

【補足/対策】
具体策として: (1) 紹介元医療機関への訪問強化（現在月10.5件→15件目標）、(2) 紹介減少が大きい整形外科・消化内科・耳鼻科での地域連携強化、(3) ベッドコントロール委員会の機能強化、(4) 外来化学療法のさらなる拡充（月300件目標）を提案する。

Q6-2. マイナ保険証の利用率向上は経営にどう影響するか。

【結論】
マイナ保険証利用率は急速に向上しており（直近65.3%）、医療DX推進体制整備加算等の算定要件充足に貢献。直接的な増収効果もある。

【根拠データ】
・資料1-1/資料10：マイナ保険証利用率推移
  ・2月35.3%→4月37.9%→8月44.8%→12月65.3%（右肩上がり）
  ・年度平均44.0% vs 目標45.0%（ほぼ達成）
・直近12月は65.3%と大幅に上昇

【補足/対策】
2024年12月の健康保険証廃止に伴い、利用率は今後も上昇する見込み。医療DX推進体制整備加算の施設基準要件（マイナ保険証利用率の一定水準

以上）の確保に向けて、引き続き窓口での声かけとシステム環境の整備を継続する。

Q6-3. ダヴィンチ手術の活用は順調か。更なる拡大は可能か。

【結論】
ダヴィンチ手術は月平均10.2件で目標10件を達成。安定した稼働だが、更なる拡大の余地はある。

【根拠データ】
・資料10：ダヴィンチ手術件数 累計112件（月平均10.2件）vs 目標月10件
・前年度実績 年間105件（月平均8.8件）から+1.4件/月の増加
・月別では11月12件、1月12件と2桁台後半も実現

【補足/対策】
現在のデータからは適応術式の内訳が不明。追加で診療科別・術式別のダヴィンチ使用実績データが必要。泌尿器科（年度合計429件）や外科（年度合計976件）での適応拡大の可能性を検討すべき。ロボット支援手術は高単価であるため、件数増は入院単価の更なる向上に直結する。

Q6-4. 地域連携の弱体化を食い止めるために何が必要か。

【結論】
紹介件数の減少（月平均△102件）は組織的な取組み強化で対応すべき重要課題。特に上位紹介元との関係維持と新規紹介元の開拓が必要。

【根拠データ】
・資料7：紹介件数 累計12,652件 vs 前年度15,022件（月平均1,150件 vs 1,252件）
・逆紹介件数 累計13,225件 vs 前年度15,315件（月平均1,202件 vs 1,276件）
・資料7-2：紹介減少が大きい医療機関（3件以上減少）27施設
  ・明大前クリニック △10件、放友クリニック △5件 等
・資料10：医師訪問件数 月平均10.5件 vs 目標10件（達成）
・地域医療機関からの緊急診療依頼謝絶率 11.2% vs 目標10.0%（わずかに未達）

【補足/対策】
具体策: (1) 紹介減少が顕著な27施設への集中的なフォローアップ訪問、(2) 医師訪問件数の目標を月15件に引き上げ、(3) 紹介患者の受入拒否（特にベッド満床）の解消、(4) 紹介元への迅速な診療報告書の送付（現在のデータからは送付状況不明。追加データ要）、(5) 逆紹介率が低い乳癌センター（12%）、形成外科（32%）、漢方（33%）の逆紹介推進による双方向連携の強化。

---

7. 土曜日実績関連（2問）

Q7-1. 土曜日の外来・手術実績はどうか。

【結論】
3月の土曜日実績は、外来1,619人（週平均404.75人）、手術12件（週平均3件）、入院44人（週平均11人）であり、土曜日も一定の診療規模を維持している。初診159人（初診割合9.8%）と、平日と比較して初診割合がやや高い傾向がある。

【根拠データ】
・資料1-3：令和8年3月 土曜日実績
  ・外来：月間1,619人（週平均404.75人）

  ・初診：159人（初診割合9.8%）
  ・手術：月間12件（週平均3件）、全身麻酔8件、局所麻酔4件
  ・入院：月間44人（週平均11人）
・週間変動：
  ・第2週（3/14）：外来492人（月間最多）
  ・第3週（3/21）：外来323人（月間最少）
  ・最多週と最少週の差：169人（最多週の約1.5倍の開き）

【補足/対策】
土曜日の初診割合9.8%は、平日の初診率（年度累計7.4%）を上回っており、平日に受診が困難な患者層の受け皿として機能していると考えられる。手術12件のうち全身麻酔が8件（66.7%）と、土曜日でも本格的な手術が実施されている。土曜日の手術枠の安定的な活用は、年間手術件数6,336件の底上げにも寄与しており、引き続き効率的な運営を維持すべきである。

Q7-2. 土曜日の運営体制に課題はないか。

【結論】
週間変動が大きく（最多492人 vs 最少323人、差169人）、特定の週に患者が偏る傾向が見られる。運営体制の平準化と予約管理の精緻化が課題である。

【根拠データ】
・資料1-3：令和8年3月 土曜日 週間変動
  ・第1週：外来数は中間水準
  ・第2週（3/14）：492人（最多）
  ・第3週（3/21）：323人（最少）
  ・第4週：中間水準
・最多週と最少週の変動幅：169人（最多週比△34.3%）
・入院：週平均11人で比較的安定

【補足/対策】
第2週と第3週の外来患者数の差が169人と大きく、スタッフ配置や検査枠の効率性に影響を与えている可能性がある。変動要因として祝日の影響（3/21は春分の日に近接）や診療科別の予約偏在が考えられる。対策として: (1) 予約枠の週間平準化（特定の診療科が特定週に集中していないか確認）、(2) 患者数が少ない週の予約誘導、(3) 土曜日の診療体制（医師・看護師配置）を患者数変動に応じた柔軟なシフトとする仕組みの検討が必要。また、土曜日の初診割合9.8%を活かし、平日初診が困難な患者の土曜日受診を積極的に案内することで、外来患者数の底上げに活用できる余地がある。

---

8. 前年度対比関連（4問）

Q8-1. 前年度と比較して、大橋病院の経営状況は改善しているのか悪化しているのか。

【結論】
予算対比では未達だが、前年度対比では明確に改善。粗利益は前年度の2倍以上（55,297→122,991千円、+122.4%）に増加。

【根拠データ】
・資料1：大橋病院 4～2月累計 収入合計 15,290,465→15,841,950千円（+551,485千円、+3.6%）
・入院収入：前年度比+331,555千円（+3.3%）
・外来収入：前年度比+119,113千円（+2.4%）
・粗利益：55,297→122,991千円（+67,694千円、+122.4%）

・粗利益率：0.4%→0.8%（+0.4ポイント）
・入院単価：97,592→101,517円（+3,925円、+4.0%）
・外来単価：21,551→22,841円（+1,290円、+6.0%）

【補足/対策】
3病院中、粗利益が前年度比で改善したのは大橋のみ（大森△32.9%、佐倉△26.4%）。予算が高水準に設定されていた面もあり、実績ベースでは着実に改善。入院単価+4.0%、外来単価+6.0%と診療単価の向上が収益改善の主因であり、DPC管理や外来化学療法の拡充といった質的改善の成果が表れている。

Q8-2. 収入が前年度比+3.6%増加しているのに、なぜ予算未達なのか。

【結論】
予算が前年度実績を上回る高い水準で設定されていたため。特に外来患者数の予算前提が実態より高い。

【根拠データ】
・資料1：大橋病院 収入合計 実績15,841,950千円 vs 予算16,153,885千円（△311,935千円、△1.9%）
・前年度実績15,290,465千円に対しては+551,485千円（+3.6%）
・外来収入：前年比+2.4%だが予算対比では△5.3%
・外来患者数：予算910人/日に対し実績852人/日。前年度895人/日と比較しても△43人
・予算は前年度実績を約5.6%上回る水準で設定されていた

【補足/対策】
来年度予算策定では、外来患者数の前提を前年度実績ベースで設定することを検討すべき。過大な予算設定は現場のモチベーション低下を招く恐れがある一方、収入が前年度比で着実に成長している事実は適切に評価すべきである。

Q8-3. 人件費の前年度対比はどうか。予算超過は構造的な問題か。

【結論】
累計ベースの前年度対比は+0.3%（+22,320千円）と極めて抑制されている。2月単月の+7.6%は一時的要因の可能性がある。

【根拠データ】
・資料1：大橋病院 4～2月累計 人件費 6,496,788→6,519,108千円（+22,320千円、+0.3%）
・3病院中最低の伸び率（大森+1.4%、佐倉+0.6%）
・一方、予算に対しては+105,674千円（+1.6%）の超過
・2月単月：440,637千円 vs 前年度409,471千円（+31,166千円、+7.6%）

【補足/対策】
2月単月の+7.6%は賞与関連や一時金の計上タイミングの影響が考えられる。通年ベースの人件費管理は良好と評価できる。予算超過の+1.6%も、予算が前年度比で引き上げられていない場合は構造的問題というより予算設定の問題である可能性がある。人件費比率41.2%は3病院中最高であり、収入増による比率改善が望ましい。

Q8-4. 3病院の中で前年度対比の改善度合いが最も大きいのはどこか。

【結論】
粗利益の改善では大橋が圧倒的。収入成長率では大森がトップ。

【根拠データ】

・粗利益前年比：大橋+122.4%、大森△32.9%、佐倉△26.4%
・収入前年比：大森+4.4%、大橋+3.6%、佐倉+1.6%
・人件費前年比：大橋+0.3%、佐倉+0.6%、大森+1.4%
・大橋は「収入+3.6%、支出+3.2%」で収支バランスが取れている

【補足/対策】
大森は収入+4.4%だが医療経費+9.7%増で利益を圧迫。佐倉は収入の伸び悩み（+1.6%）が課題。大橋は収入成長と費用抑制のバランスが3病院中最も良好であり、この点は経営努力として評価される。来年度は大橋の改善モデル（単価向上×コスト管理）を他院にも展開することを検討すべきである。

---

9. 診療科別実績関連（4問）

Q9-1. 診療科別で見たとき、最も収益に貢献している科と最も課題のある科はどこか。

【結論】
最大貢献は外科（外来+入院合算で前年比+3,130万円）、最大課題は整形外科（△2,492万円）。

【根拠データ】
・外科は化学療法（注射+649,520点）と手術件数増（手術+860,131点）で全項目増
　・外来+681万円、入院+2,449万円
・整形外科は患者数激減（外来△290人、入院△221人）が主因で、紹介件数△543件が直結
　・外来△263万円、入院△2,229万円
・その他の成長科：泌尿器科+687万円、消化器内科+606万円、放射線科+466万円、産婦人科+388万円
・その他の課題科：脳神経外科△1,617万円、心臓血管外科△1,563万円、眼科△560万円、リウマチ膠原病痛風△507万円

【補足/対策】
外科の成長は外来化学療法（+255件/年）と連動しており、化学療法室の体制維持が外科の収益成長の前提条件となる。整形外科は紹介拒否→信頼低下→紹介減の悪循環が懸念される。紹介件数2,192→1,649件（△24.8%）と全科最大の減少幅であり、紹介元医療機関との関係回復が急務。

Q9-2. 外来の患者数が減少しているのに外来収入が増加しているのはなぜか。

【結論】
一人当たり単価が+11.6%上昇し、患者数△8.5%を相殺している。化学療法の注射が主因。

【根拠データ】
・外来全体：患者△8.5%だが単価+11.6%で総額+2.1%（+952万円）
・外来全体で注射+2,291,603点（化学療法）
・診療科別注射増加上位：
　・泌尿器科+672,812点（前年比2倍超）
　・外科+649,520点
　・循環器内科+522,655点

【補足/対策】
化学療法の単価効果は持続的と考えられるが、患者数減少が続けば注射以外の基本収入（再診料、検査等）が縮小するリスクがある。特に泌尿器科は化学療法件数が2倍以上に急増しており、ダヴィンチ手術の単価効果と合わせて今後も成長が期待される一方、化学療法患者の偏在による体制リスクにも留意が必要。

Q9-3. 入院収入の減少は何が原因か。手術件数は増えているのになぜ減るのか。

【結論】
手術材料費△2,191万円が最大の要因。全麻手術件数は増加しているが、高額手術材料を使う症例（整形インプラント、脳外デバイス、心臓弁等）が減少している。

【根拠データ】
- 入院全体：患者△3.3%、単価△0.4%で総額△3.6%（△3,089万円）
- 手術材料△2,191万円が入院最大の減収要因
- 手術材料の減少内訳：
  - 循環器内科△1,010,260点
  - 整形外科△618,194点
  - 脳神経外科△423,449点
  - 心臓血管外科△406,085点
- 一方、外科は手術+860,131点の増

【補足/対策】
手術の「量」は増えているが「質（単価）」が変化している。眼科の局麻手術が件数では多いが単価は低い。高単価手術（整形インプラント手術、心臓血管外科手術、脳神経外科手術等）の回復が入院収入改善の鍵となる。整形外科の患者数回復と脳神経外科・心臓血管外科の症例確保に向けた紹介強化が具体策となる。

Q9-4. 整形外科の大幅な収益減少にどう対応するのか。

【結論】
外来・入院合算で△2,492万円は全科最大。紹介件数の回復が最優先課題。

【根拠データ】
- 紹介件数：2,192→1,649件（△543件、△24.8%）
- 外来患者：△290人
- 入院患者：△221人
- 手術：△446,345点
- 手術材料：△618,194点
- 外来△263万円、入院△2,229万円

【補足/対策】
整形外科の紹介拒否理由「ベッド満床」が2月に3件発生しており、病棟横断的な受入体制の構築が急務である。具体策として: (1)
医師による紹介元医療機関への訪問強化（紹介減少が大きい施設を優先的にフォロー）、(2)
空床情報のリアルタイム共有の仕組み導入（他科病棟への一時受入を含む柔軟なベッドコントロール）、(3)
手術枠の確保と効率的な運用により入院回転率を維持し、新規紹介の受入余力を確保することが必要。紹介件数△543件は年間約2,500万円の減収に直結しており、月45件の紹介回復を目標とすべきである。

補足：現在のデータから判断できない事項

以下の項目については、今回の資料からは判断が困難であり、追加データが必要である。

No.	項目	必要なデータ

1	診療科別の収支損益	診療科別原価計算データ
2	看護師配置の充足状況	病棟別看護配置実績・7対1要件の充足状況
3	DPC機能評価係数IIの詳細	効率性・複雑性・カバー率等の各係数データ
4	医師の働き方改革への影響	医師の時間外労働実績・診療体制への影響
5	患者満足度・クレーム状況	患者アンケート結果・投書データ
6	紹介状返書の送付率・送付日数	病診連携室の返書管理データ
7	来年度の設備投資計画	中期経営計画・設備投資予算書
8	他院との機能分化の方向性	地域医療構想に基づく将来計画

本Q&A集は2025年度2月実績および3月の手術データ（資料3確定済み）・土曜日実績（資料1-3）に基づき作成。その他の3月実績データが確定次第、最終版へ更新予定。